

INFORME RECOMENDACIONES EN TÉCNICAS DE AEROSOLTERAPIA EN LOS PUNTOS DE URGENCIA DEL DISTRITO CÓRDOBA Y GUADALQUIVIR

Fecha informe: 20-12-2022

Técnico: M.^a Teresa Valdivia Valdivia (TSPRL Higiene Industrial)

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 1.3

Servicio Andaluz de Salud



ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN.....	2
2 REFERENCIAS.....	2
3 DATOS OPERATIVOS.....	2
4 RECOMENDACIONES.....	3



1 INTRODUCCIÓN

El objeto del presente informe es establecer las recomendaciones para el uso de técnicas de Aerosolterapia en los puntos de Urgencia del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir.

Esta actuación se realiza tras la solicitud motivada por parte del Director de Salud, Jose Antonio Gascón Jiménez respecto a este tema a la UPRL 1.3.

2 REFERENCIAS

En la pagina del Ministerio de Sanidad, “Documentos técnicos para profesionales”, establece que:

“ Los documentos de manejo clínico de casos de COVID-19 que se publicaron en esta web del Ministerio de Sanidad, en el momento actual están desactualizados. Al inicio de la pandemia existía una gran necesidad de generar protocolos de actuación comunes que en su momento fueron útiles para todos. En este momento muchas instituciones y sociedades ha elaborado sus propios protocolos que actualizan y adaptan a los distintos ámbitos en los que trabajan. “

Por ello, para este informe se ha tomado como referencia:

[1]Documento de consenso respecto al soporte respiratorio no invasivo en el paciente adulto con insuficiencia respiratoria aguda secundaria a infección por SARS-CoV-2, elaborado entre la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor (SEDAR).

3 DATOS OPERATIVOS

El riesgo de transmisión de infección a través de núcleos de gotitas y aerosoles puede aumentar durante los tratamientos con nebulizador debido al potencial de generar un alto volumen de aerosoles respiratorios que pueden ser propulsados a una distancia mayor que la involucrada en el patrón de dispersión natural. Además, las partículas más grandes pueden estimular la tos de pacientes y transeúntes y, por lo tanto, aumentar el riesgo de propagación de la enfermedad. La terapia con nebulizador en pacientes con infección pandémica por COVID-19 tiene el potencial de transmitir COVID-19 potencialmente viable a sujetos susceptibles.



4 RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES GENERALES

- El personal sanitario que atienda casos en investigación o confirmados para infección por COVID-19 en tratamiento con SRNI deben llevar un equipo de protección individual (EPI) para la prevención de infección durante los procedimientos de generación de aerosoles que se han asociado con un aumento del riesgo de transmisión de patógenos aéreos. Las medidas preventivas deben estar dirigidas a microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya:

* Una mascarilla de alta eficacia FFP2 o preferiblemente FFP3 si hay disponibilidad.

* Gafas de protección de montura integral o protector facial completo.

* Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo, pudiéndose ayudar de un gorro de quirófano.

* Guantes.

* Batas de protección microbiológica impermeables de manga larga.

- La ubicación del paciente se relaciona con la posibilidad de realizar procedimientos generadores de aerosoles. Se recomienda ubicar al paciente en una habitación que disponga de presión negativa. Si este tipo de sala no está disponible, se le atenderá al paciente en una habitación o box de uso individual con baño, con ventilación natural o climatización independiente. La puerta de la habitación deberá permanecer siempre cerrada.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS TERAPIA INHALADA

La administración de terapia inhalada se realizará preferentemente con dispositivo MDI y cámara espaciadora.

La terapia con nebulización solo debería usarse en las siguientes situaciones:

- Enfermedad respiratoria grave y potencialmente mortal (p.ej., aquellos con hipoventilación o compromiso de ventilación, EPOC grave, fibrosis quística).
- Pacientes que no cooperan o no pueden seguir las instrucciones requeridas para un inhalador de dosis medida (MDI) con uso de cámara-válvula espaciadora.
- Pacientes con mala respuesta al MDI con cámara-válvula espaciadora.

Para reducir el riesgo de transmisión de todas las enfermedades respiratorias infecciosas todos los profesionales sanitarios deben considerar seriamente evitar el uso de nebulizadores abiertos en los



pacientes con respiración espontánea si no se dispone de los dispositivos mencionados anteriormente. Así, se mantendrá la seguridad de los pacientes y del personal sanitario.

Por tanto, si se precisa utilizar aerosolterapia, se recomienda utilizar dispositivos de malla vibrante con pipeta bucal o mascarilla, limitando la dispersión y poniendo encima una mascarilla quirúrgica.



Se desaconsejan los sistemas jet por la mayor capacidad de dispersión de partículas al ambiente. De ser necesarios, es imprescindible colocar mascarilla quirúrgica al paciente durante la nebulización.

Para utilizar terapia inhalada junto con SRNI se recomiendan observar los siguientes puntos:

- La recomendación general para administrar la terapia inhalada es utilizar cartuchos presurizados con un adaptador o cámara espaciadora. En caso de utilizar VMNI se colocará en la rama inspiratoria del circuito, coordinando la pulsación con la inspiración del paciente.
- Si se utiliza aerosolterapia son de elección los nebulizadores de malla vibrante con adaptación al codo de la interfase. Como segunda opción se puede utilizar el nebulizador de malla vibrante con una pieza en T al circuito de la VMNI. Al tratarse de un «sistema cerrado», no se dispersan al ambiente si la fuga perimascarilla está bien controlada.
- Los nebulizadores tipo jet con tubo en T generan mayores turbulencias y partículas de mayor tamaño y mayor facilidad de dispersión de partículas.

Fdo. M.^a Teresa Valdivia Valdivia

Técnico en Prevención de Riesgos Laborales
Higiene Industrial